Источник

Учебный отчёт врача по результатам осмотра и КТ грудной клетки.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР. Все сведения вымышлены; это не документ реального пациента и не медицинское назначение.

Номер исследования: DEMO-REPORT-001

Дата исследования: 05.10.2026

Место проведения: Учебная клиника MediPath

ФИО пациента: Тестов Пациент Примерович

Описание

На приёме пациент сообщает о сухом кашле преимущественно вечером. Кашель отмечается около трёх недель, количество эпизодов в течение дня меняется. Мокроту, кровохарканье и боль в грудной клетке отрицает. Сон иногда прерывается из-за кашля. Повседневную нагрузку переносит в привычном объёме, выраженной одышки в покое со слов пациента нет. Температуру дома измеряет нерегулярно; значение на момент осмотра составляет 36,6 °C. Сведения об изменении массы тела и длительности курения в представленном материале отсутствуют.

Общее состояние на момент осмотра удовлетворительное. Сознание ясное, речь последовательная. Кожа обычной окраски, видимой сыпи нет. Частота дыхания составляет 16 в минуту. Дыхательные движения грудной клетки симметричны. При выслушивании дыхание определяется с обеих сторон, явные свистящие хрипы в записи осмотра не отмечены. Частота пульса составляет 72 в минуту, артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Периферические отёки в осмотре не описаны.

Описание

В представленном описании КТ органов грудной клетки в нижней доле правого лёгкого указан единичный очаг округлой формы размером 4 мм. Контуры очага обозначены как ровные. Других очагов в этом описании нет. Плевральный выпот не выявлен. Просвет трахеи и крупных бронхов сохранён. Средостение расположено по средней линии; объёмные образования средостения в тексте не описаны. Размеры лимфатических узлов отдельно не приведены. Детальная характеристика плотности очага в исходной записи отсутствует.

Предыдущие изображения КТ и отдельное сравнительное заключение на приёме не представлены. Поэтому в записи нет достоверного сравнения размеров очага за разные даты. Изменение его размера, длительность существования и происхождение по этому материалу не определены. Описание очага и жалоба на кашель зафиксированы раздельно; причинная связь между ними в отчёте не установлена. Лабораторные результаты и показатели функции внешнего дыхания в комплекте документов отсутствуют. Перечень постоянных лекарств со слов пациента в этой записи не уточнён. Значения, которых нет в исходных материалах, в отчёт не добавлены.

Заключение

В представленном описании КТ отмечен единичный очаг нижней доли правого лёгкого размером 4 мм. Плевральный выпот не выявлен. Пациент сообщает о сухом кашле около трёх недель. Данных предыдущих изображений для сравнения нет. Причина кашля и происхождение очага по материалам данного приёма не установлены; окончательный диагноз в этом отчёте не сформулирован. Результат осмотра и текст КТ требуют совместного рассмотрения специалистом.

Рекомендации

Рекомендована консультация пульмонолога в течение 2 недель. К приёму подготовить имеющиеся изображения КТ и их описания, доступные выписки и список постоянно принимаемых лекарств. Предоставить предыдущие изображения для сопоставления. В данном отчёте нет назначения лекарственных препаратов и схемы лечения. Вопрос о составе дальнейшего обследования оставлен для обсуждения на приёме.